Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы

Удаление слюнной железы, расположенной под нижней челюстью

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Сторона: ☐ Правая ☐ Левая

Причина операции: ☐ Камень слюнной железы / повторяющееся воспаление ☐ Образование в железе ☐ Другое _____

Мониторинг нерва: ☐ Будет использоваться ☐ Не будет использоваться

Результат визуализации / биопсии: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Поднижнечелюстная железа — это слюнная железа, которая расположена с каждой стороны сразу под нижней челюстью и выделяет слюну в полость рта. Она вырабатывает значительную часть слюны; однако, поскольку такая же железа с другой стороны, а также слюнные железы перед ушами и под языком продолжают работать, **удаление одной железы у большинства пациентов не вызывает сухости во рту**.

Эту операцию чаще всего выполняют из-за **камней слюнной железы** и вызванных ими **повторяющихся отёков и воспалений**. Камень препятствует оттоку слюны в рот, из-за чего во время еды под челюстью возникает болезненный отёк и случаются повторные инфекции. Реже операция требуется при **образовании (опухоли)** в железе. Среди образований поднижнечелюстной железы доля злокачественных опухолей выше, чем среди образований околоушной железы; поэтому для окончательного диагноза важно удалить железу и исследовать её под микроскопом.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Рядом с железой проходят три нерва: ветвь нерва, которая двигает нижнюю губу, нерв, обеспечивающий чувствительность языка, и нерв, который двигает язык. Цель операции — полностью удалить железу, сохранив эти нервы.

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится под общим наркозом в условиях операционной.

1. **Разрез:** Примерно на 2–3 см ниже края нижней челюсти, параллельно естественной кожной складке шеи, делается разрез длиной обычно 4–6 см. Расположение разреза достаточно низко под челюстью помогает защитить ветвь нерва, которая двигает нижнюю губу.
2. **Защита нервов:** Рассекают тонкий мышечный слой под кожей (платизму). Ветвь нерва, которая двигает нижнюю губу (краевая ветвь нижней челюсти), защищают — либо визуально контролируя её, либо работая в безопасном слое тканей.
3. **Удаление железы:** Железу отделяют от окружающих тканей и перевязывают питающие её сосуды. Слюнной проток аккуратно отделяют от нерва, обеспечивающего чувствительность языка (язычного нерва), затем перевязывают и пересекают. Нерв, который двигает язык (подъязычный нерв), сохраняют. Если в протоке есть камень, по возможности удаляют и дальнюю часть протока.
4. **Патогистологическое исследование:** Удалённую железу отправляют на патогистологическое исследование; результат обычно готов в течение 1–2 недель.
5. **Завершение операции:** Проводится остановка кровотечения, обычно устанавливается тонкий **дренаж**, и кожу зашивают косметическими швами.

Если в полости рта рядом с местом, где проток открывается в рот, находится камень, иногда его могут дополнительно удалить отдельно через рот. Это будет обсуждено с вами до операции.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общий наркоз	Около 1–2 часов	Обычно 1 ночь; выписка после удаления дренажа

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Прекращение повторяющихся болезненных отёков и воспалений, вызванных камнями
- Отсутствие необходимости в повторных курсах антибиотиков
- Удаление образования в железе и установление окончательного диагноза

После операции по поводу камней и хронического воспаления жалобы полностью проходят у **более чем 90%** пациентов. Если в части протока, оставшейся во рту, сохраняется камень или образуется новый, в редких случаях отёк дна полости рта может сохраняться. При доброкачественных образованиях операция обычно обеспечивает стойкое излечение; при злокачественных опухолях может потребоваться дополнительное лечение.

4 Другие варианты лечения

- **Медикаментозное и поддерживающее лечение:** Обильное питьё, кислые продукты для усиления слюноотделения, массаж, тёплые компрессы и антибиотики в периоды воспаления. Это может облегчить жалобы, но не устраняет камень.
- **Удаление камня через рот:** Камни, расположенные в части протока ближе ко рту и прощупываемые пальцем, можно удалить через небольшой разрез в полости рта с сохранением железы.
- **Эндоскопия слюнного протока (сиалоэндоскопия):** Камни подходящего размера и расположения можно удалить изнутри протока с помощью тонкого эндоскопа; этот метод доступен не в каждом центре и подходит не для каждого камня.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Наблюдение:** При небольших образованиях, которые считаются доброкачественными, в редких случаях может обсуждаться наблюдение; однако для окончательного диагноза при образованиях этой железы обычно рекомендуется операция.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Без операции отёки и воспаления, вызванные камнями, могут продолжать повторяться; в редких случаях вокруг железы может развиться абсцесс (скопление гноя), требующий неотложного лечения. Если в железе есть образование, окончательный диагноз поставить нельзя; злокачественная опухоль без лечения может прогрессировать.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией выполняются анализы крови и визуализирующие исследования (УЗИ и при необходимости КТ/МРТ); вас осмотрит анестезиолог.
- В течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (пожалуйста, следуйте указаниям анестезиолога).
- Если в железе есть активное воспаление, операцию обычно планируют после того, как воспаление будет вылечено.
- У мужчин в день операции могут подстричь бороду в зоне разреза.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин E, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 24–48 часов	Под челюстью будут ощущаться лёгкая или умеренная боль, стянутость и отёк, которые контролируются обезболивающими. При глотании может быть небольшой дискомфорт. Дренаж обычно удаляют на 1-й день. Рекомендуется спать с приподнятой головой. Мягкую пищу можно начинать есть сразу.
1-я неделя	Вы можете вернуться к повседневным делам. Швы обычно снимают на **5–7-й день**. Онемение выше разреза, вдоль края нижней челюсти и вокруг разреза — это нормально. Результат патогистологического исследования вам сообщат в этот период или вскоре после него.
2–4-я недели	Большинство людей возвращаются к сидячей работе в течение 1 недели. Интенсивные физические нагрузки и подъём тяжестей следует отложить примерно на **2 недели**. Уплотнение и небольшой отёк в области разреза постепенно уменьшаются.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2–6-й месяцы	Рубец постепенно светлеет и часто становится незаметным в кожной складке шеи. Если была временная слабость нерва или снижение чувствительности, они обычно проходят в этот период.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Боль, стянутость и отёк под челюстью; лёгкий дискомфорт при глотании
- Онемение кожи вокруг и ниже разреза
- Рубец на шее (со временем светлеет)

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Временная слабость нижней губы** — Из-за натяжения во время операции ветви нерва, которая опускает нижнюю губу (краевой ветви нижней челюсти), примерно у **10–20 из 100** пациентов при улыбке или разговоре возникает лёгкая асимметрия нижней губы на этой стороне. Это косметическая проблема, обычно она не мешает есть и пить и в большинстве случаев **проходит в течение нескольких недель или нескольких месяцев**.
- **Уплотнение и онемение в области разреза** — В первые недели уплотнение и снижение чувствительности ниже разреза встречаются часто и уменьшаются в течение нескольких месяцев.

Нечастые состояния

- **Кровотечение и гематома** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов под кожей может скопиться кровь. Если гематома большая, может потребоваться её удаление и остановка кровотечения в операционной.
- **Раневая инфекция** — Может возникнуть у **1–3 из 100** пациентов, особенно если железа была воспалена; обычно проходит при лечении антибиотиками, в редких случаях требуется дренирование.
- **Снижение чувствительности одной половины языка** — Из-за воздействия на нерв, обеспечивающий чувствительность языка (язычный нерв), онемение или покалывание на этой стороне языка возникает примерно у **1–3 из 100** пациентов. Чаще всего это временно; в редких случаях может быть стойким и также влиять на восприятие вкуса.
- **Скопление жидкости (серома)** — Скопление жидкости под разрезом; обычно проходит после откачивания иглой и наложения давящей повязки.
- **Камень, оставшийся в протоке** — В части слюнного протока, оставшейся во рту, может сохраниться камень или образоваться новый, что может вызвать отёк или воспаление дна полости рта. При необходимости его удаляют через рот с помощью небольшой процедуры.
- **Заметный или грубый рубец** — В зависимости от индивидуальной предрасположенности рубец может утолщаться или оставаться заметным; можно применять методы лечения рубцов.
- **Западение под челюстью** — На месте железы может образоваться небольшое углубление и разница между двумя сторонами; обычно это незаметно.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Стойкая слабость нижней губы** — **Примерно у 1–3 из 100** пациентов или реже может остаться стойкое ограничение подвижности нижней губы на этой стороне и асимметрия улыбки. Если это заметно, можно применить лечение, например уравновешивание другой стороны с помощью ботулотоксина.
- **Слабость движений языка** — Повреждение нерва, который двигает язык (подъязычного нерва), встречается **очень редко**. Если оно происходит, может возникнуть слабость этой половины языка и затруднения речи и глотания; при стойком повреждении может потребоваться логопедическая терапия речи и глотания.
- **Большая гематома шеи с нарушением проходимости дыхательных путей** — Очень редко быстро увеличивающееся скопление крови может сдавливать шею и вызывать затруднение глотания или **дыхания**. Это неотложное состояние: гематому необходимо немедленно удалить в операционной, а в редких случаях может потребоваться обеспечение проходимости дыхательных путей (интубация или трахеостомия).
- **Окончательный патогистологический диагноз отличается от предварительного** — Даже в железе, в которой предполагались камни или воспаление, окончательное патогистологическое заключение может выявить неожиданную опухоль. Если обнаружена злокачественная опухоль, может потребоваться дополнительное лечение, например удаление лимфатических узлов шеи или лучевая терапия.
- **Сухость во рту** — У большинства пациентов удаление одной железы проходит незамеченным; однако сухость во рту может стать заметной у пациентов, ранее получавших лучевую терапию, страдающих некоторыми ревматическими заболеваниями или принимающих лекарства, вызывающие сухость во рту.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Быстро нарастающий отёк шеи**, особенно с **затруднением дыхания или глотания** (неотложное состояние — немедленно звоните 112)
- **Непрекращающееся кровотечение** из дренажа или раны
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающее покраснение, боль, ощущение жара или гнойное отделяемое из раны
- Выраженный отёк языка или дна полости рта
- **Новое выраженное затруднение** речи или глотания

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- В первые 48 часов держите рану сухой; после этого можно принять короткий душ, как вам объяснят.
- В первые дни выбирайте мягкую, тёплую (не горячую) пищу; следите за гигиеной полости рта и пейте много жидкости.
- Защищайте рубец от солнца не менее 6 месяцев (солнцезащитный крем с высоким фактором защиты).
- Обязательно обсудите с врачом результат патогистологического исследования и план дальнейшего наблюдения.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что окончательный диагноз будет поставлен после операции по результатам патогистологического исследования и что в зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

- ☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.
- ☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.